جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صباح احمد محمد صالح
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** ش-شحاته الجمل
رقم البطاقة : 25505010104385 **رقم التليفون :** 01115093601 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-05-1955 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: صباح احمد محمد صالح
National ID: 25505010104385

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



صباح
عبدالقادر بركات حسن
١١ ش ١٠ - منشية جمال عبدالناصر
حلوان - القاهره

٢٦٨ ١٢ ١٤ ٠١ ٠٣٤ ٤٩

JC4657065



٢٦٨١٢١٤٠١٠٣٤٤٩ ٢٠٢١/١٠
ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
ابراهيم على محمد النعمانى
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١٠/٢٦

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :15-7-2026

جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى.

والبحث تبين أن

السيد (ة) صباح عبد القادر بركات بطاقة رقم 26812140103449

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

تاريخ الطباعه :15-7-2026

الموظف المختص
محمود عبدالله

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2024400

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

Patient ID: 97278	Patient Name English: Sabah Abdalkader Barakat Hassan
Age: ٥٧ سنة, ٢ شهر	2026/07/15 10:01:48 AM :Report Date

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: right retro-areolar pathologically proven papillary lesion.

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: mild background enhancement

ACR: c (heterogenous mammary parenchyma that may obscure small lesions)

RIGHT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images**: show Retro-areolar partially circumscribed partially obscured equal density mass lesion.
- UOQ posterior third focal asymmetry with few overlying amorphous microcalcifications.
- Closely related to such asymmetry two circumscribed fat containing lesions.
- **Recombined (Post contrast) images**: show retro-areolar circumscribed heterogeneously enhancing mass lesion of low conspicuity measuring 15 x 14 x 12 mm.
- UOQ, posterior third, 10 cm from nipple, heterogeneously enhancing mass lesion of high conspicuity measuring 22 x 21 x 21 mm.
- Closely related two heterogeneously enhancing mass lesions (seen 5 mm from the forementioned mass lesion).
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary US**: retro-areolar intraductal mass lesion, pathologically proven papillary.
- 10 o'clock, posterior third, 6 mm deep to the skin, indistinct anti-parallel hypoechoic suspicious mass lesion.
- 10 o'clock, posterior third, 5 mm from the forementioned mass lesion three intra-mammary indeterminate lymph nodes, the largest two measured 11 x 5 mm and 11 x 7.6 mm with 2mm & 2 mm cortical thickness respectively.
- Non-specific axillary nodes.

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images** No masses, asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show no pathological mass or non-mass enhancement.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary ultrasound: benign findings.**

IMPRESSION:

RIGHT BREAST: (BIRADS 4b= moderately suspicious) UOQ posterior third mass enhancement with adjacent indeterminate intra-mammary lymph nodes & retro-areolar pathologically proven papillary enhancing mass lesion.

LEFT BREAST: (BIRADS 2= benign) benign findings.

RECOMMENDATION:

For US guided Tru-cut biopsy of the newly discovered UOQ posterior third suspicious mass lesion & adjacent indeterminate intra-mammary lymph nodes.

Best regards,

Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

Dr. Amira Shaheen

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	صباح احمد محمد	**Case No.**	**342460**
Sex/Age	**Female 71 Y**	**Patient No.**	**24885**
Registered Date	**16/7/2026 01:58:33 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**19/9/2026 03:02:50 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**23/9/2026 10:39:17 AM**	**Pathology No.**	**2247/26**

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5) diagnosed "Invasive duct carcinoma grade 2".

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 16/07/2026, at 1:58pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
-Five fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Present.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Present.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 99% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 10%.

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	صباح احمد محمد	**Case No.**	**342460**
Sex/Age	**Female 71 Y**	**Patient No.**	**24885**
Registered Date	**16/7/2026 01:58:33 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**19/9/2026 03:02:50 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**23/9/2026 10:39:17 AM**	**Pathology No.**	**2247/26**

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: Low (score 1+).
- Ki67%: 10%.

***Scoring system: "ER, PR"*

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

*** Scoring system: "Her2"*

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim, MD.

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]
Non-HIO Letter

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :15-7-2026 جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) صباح احمد محمد صالح بطاقة رقم 25505010104385

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :15-7-2026

الهيئة العامة للتأمين الصحى
فرع الجيزة
إدارة النظم والمعلومات
قسم المعلومات

الموظف المختص
كريمه ابراهيم

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2023852

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Patient ID: 140726-133044	Patient Name English: Sabah ahmed
:Age	2026/07/14 12:03:26 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c), with scattered partially obscured lobulated dense lesions, mainly at UOQ .
- The Left breast shows lower midline posterior 1/3 irregular ill-defined spiculated dense mass lesion with foci of calcifications within.
- Tubular density noted anterior to the lesion , middle third with suspicions linear microcalcifications within
- Scattered foci of punctate calcifications.
- **Ultrasound** revealed an irregular ill-defined hypoechoic mass lesion, noted at 5 o'clock zone c , measures 24 x 18 mm , seen resting on underlying muscle , and invading overlying skin , with peripheral color uptake on Doppler study. Adjacent anterior prominent ducts seen extending anteriorly to zone b
- Small oval hypoechoic lesion with echogenic center, seen adjacent to index mass, measures 4 x 3 mm ? IMLN
- Scattered clear cysts seen within the parenchyma , largest noted at 1 o'clock measures 11 x 8 mm .
- Retro areolar dilated ducts reach up to 3 mm in diameter.
- Normal nipple/areolar complex.
- Level I one axillary LN , globular measures 4 x 3 mm , with eccentric hilum , cortical thickness 3 mm (indeterminate).

Right breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c), with scattered partially obscured rounded dense lesions
- Scattered punctate calcifications
- No distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated scattered anechoic cysts of average size 7 mm.
- Retro areolar dilated clear ducts reach up to 3.5 mm
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 4c): 5 o'clock malignant mass lesion as described with suspected ductal extension and ipsilateral indeterminate level I axillary lymph node. Fibrocystic changes .Core needle biopsy and MRI/CESM study is recommended.**
- **Right breast (BIRADS 2): Fibrocystic changes.**

Much obliged,
Dr. RANIA AHMED, MD

Sabah Ahmed Mohamed Saleh :اسم المريض بالإنجليزية	100848 :كود المريض
2026/09/24 10:11:08 AM :تاريخ التقرير	السن: ٧١ سنة, ٤ شهر

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: Pathologically proven IDC

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: minimal background enhancement

ACR: b (scattered fibro-glandular densities)

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images**: The left breast shows ill-defined spiculated dense mass lesion at the middle 1/3 LIQ measures about 5.6 x 4.3 x 5.3 cm and about 5 cm from the nipple.
- **Recombined (Post contrast) images**: The left breast shows moderate heterogenous posteriorly located mass enhancement measures about 2x1.4cm 8cm far from nipple.
- No intra ductal extension
- Normal skin / nipple / areolar complex.

RIGHT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images** No masses, asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show no pathological uptake.
- Normal skin / nipple / areolar complex.

IMPRESSION:

LEFT BREAST: (BIRADS 6= pathological proven) Left unifocal posterior 1/3 Lower central (5-6:00) pathologically proven IDC with no intra ductal extension.

RIGHT BREAST: (BIRADS 2= benign) No pathological enhancing lesions

Best regards,

Dr. Rehab Elsheikh, MD

بطاقة تحقيق الشخصية



صباح

احمد محمد صالح

٥٦ش احمد عبدالبارى-ش شحاته الجمل

بولاق الدكرور - الجيزه

٢٥٥٠٥٠١٠١٠٤٣٨٥

KA5596621

٢٥٥٠٥٠١٠١٠٤٣٨٥ ٢٠٢٣/٠٦

ربة منزل

أنثى مسلمة أرملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٦/٠٥

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	صباح احمد محمد	**Case No.**	**342460**
Sex/Age	**Female 71 Y**	**Patient No.**	**24885**
Registered Date	**16/7/2026 01:58:33 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**19/9/2026 03:02:50 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**23/9/2026 10:39:17 AM**	**Pathology No.**	**2247/26**

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5) diagnosed "Invasive duct carcinoma grade 2".

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 16/07/2026, at 1:58pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
-Five fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Present.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Present.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 99% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 10%.

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – حصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	صباح احمد محمد	**Case No.**	**342460**
Sex/Age	**Female 71 Y**	**Patient No.**	**24885**
Registered Date	**16/7/2026 01:58:33 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**19/9/2026 03:02:50 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**23/9/2026 10:39:17 AM**	**Pathology No.**	**2247/26**

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: Low (score 1+).
- Ki67%: 10%.

***Scoring system: "ER, PR"*

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

*** Scoring system: "Her2"*

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim, MD.

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :15-7-2026 جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) صباح احمد محمد صالح بطاقة رقم 25505010104385

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :15-7-2026

الهيئة العامة للتأمين الصحى
فرع الجيزة
إدارة النظم والمعلومات
قسم المعلومات

الموظف المختص
كريمه ابراهيم

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2023852

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Patient ID: 140726-133044	Patient Name English: Sabah ahmed
:Age	2026/07/14 12:03:26 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c), with scattered partially obscured lobulated dense lesions, mainly at UOQ .
- The Left breast shows lower midline posterior 1/3 irregular ill-defined spiculated dense mass lesion with foci of calcifications within.
- Tubular density noted anterior to the lesion , middle third with suspicions linear microcalcifications within
- Scattered foci of punctate calcifications.
- **Ultrasound** revealed an irregular ill-defined hypoechoic mass lesion, noted at 5 o'clock zone c , measures 24 x 18 mm , seen resting on underlying muscle , and invading overlying skin , with peripheral color uptake on Doppler study. Adjacent anterior prominent ducts seen extending anteriorly to zone b
- Small oval hypoechoic lesion with echogenic center, seen adjacent to index mass, measures 4 x 3 mm ? IMLN
- Scattered clear cysts seen within the parenchyma , largest noted at 1 o'clock measures 11 x 8 mm .
- Retro areolar dilated ducts reach up to 3 mm in diameter.
- Normal nipple/areolar complex.
- Level I one axillary LN , globular measures 4 x 3 mm , with eccentric hilum , cortical thickness 3 mm (indeterminate).

Right breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c), with scattered partially obscured rounded dense lesions
- Scattered punctate calcifications
- No distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated scattered anechoic cysts of average size 7 mm.
- Retro areolar dilated clear ducts reach up to 3.5 mm
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 4c): 5 o'clock malignant mass lesion as described with suspected ductal extension and ipsilateral indeterminate level I axillary lymph node. Fibrocystic changes .Core needle biopsy and MRI/CESM study is recommended.**
- **Right breast (BIRADS 2): Fibrocystic changes.**

Much obliged,
Dr. RANIA AHMED, MD